医疗保健反歧视法规与文化语言适宜服务标准（中文合并版）

> 本文档由以下两份英文原文合并翻译而成：
> 1. 美国联邦法规第45篇第92部分（CFR 2025, Title 45, Vol.1, §92.10–§92.101）——第1557条反歧视规定
> 2. 全国文化与语言适宜服务（CLAS）标准（2025年6月修订版）

第一部分　美国联邦法规第45篇第92部分——第1557条反歧视规定

§ 92.10　不歧视通知

（接上段）……为残障人士提供合格的口译员以及盲文、大字版等替代格式的信息，且在这些调整、辅助器具与服务对于确保残障人士的可及性和平等参与机会确属必要时，免费且及时地提供；

（iii）受保障实体在语言协助服务（包括电子和书面翻译文件以及口头翻译）作为为英语能力有限的个人提供有意义访问的合理措施时，免费且及时地提供此类服务；

（iv）如何向受保障实体获取本条第（a）款第（1）项第（ii）目和第（iii）目所述的合理调整、适当辅助器具与服务以及语言协助服务；

（v）受保障实体根据 §92.7 指定的第1557条协调员的联系信息（如适用）；

（vi）受保障实体根据 §92.8(c) 制定的申诉程序的可用性以及如何提交申诉（如适用）；

（vii）如何向本部门民权办公室（OCR）提交歧视投诉；以及

（viii）如何访问受保障实体的网站（如有），该网站提供本条第（a）款第（1）项要求的信息。

（2）本条第（a）款要求的通知必须按下述方式在受保障实体的健康计划或活动中提供：

1. 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、登记者（包括延迟登记者和特殊登记者）以及申请人提供；
2. 根据请求提供；
3. 在受保障实体健康计划或活动网站的醒目位置发布（如有）；以及
4. 张贴在清晰醒目的物理位置，字体不小于20号无衬线字体，且位于合理预期寻求健康计划或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的位置。

（b）受保障实体可将本条第（a）款要求的通知内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 要求的通知合并，前提是合并后的通知清楚地告知个人其在第1557条及本部分下享有的公民权利，并且包含本条第（a）款第（1）项要求的各项要素。

---

§ 92.11　语言协助服务及辅助器具与服务的可用性通知

（a）受保障实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助器具与服务可用性的通知，该通知至少应说明：受保障实体在其健康计划或活动中，在为遵守第1557条或本部分而确属必要时，向其健康计划或活动的参与者、受益人、登记者和申请人以及公众成员免费提供语言协助服务和适当的辅助器具与服务。

（b）本条第（a）款要求的通知必须以英文以及受保障实体运营所在相关一个或多个州中英语能力有限的个人最常使用的至少15种语言提供，并且必须为需要辅助器具与服务以确保有效沟通的残障人士以替代格式提供。

（c）本条第（a）款要求的通知必须按下述方式在受保障实体的健康计划或活动中提供：

1. 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、登记者（包括延迟登记者和特殊登记者）以及申请人提供；
2. 根据请求提供；
3. 在受保障实体健康计划或活动网站的醒目位置发布（如有）；
4. 张贴在清晰醒目的物理位置，字体不小于20号无衬线字体，且位于合理预期寻求健康计划或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的位置；以及

（5）在受保障实体提供以下形式的电子和书面通讯中提供：

1. §92.10 要求的不歧视通知；
2. 45 CFR 164.520 要求的隐私实践通知；
3. 申请表和接诊表；
4. 资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明（Explanation of Benefits），以及申诉和投诉权利的通知；
5. 与个人权利、资格、福利或服务相关、需要或请求参与者、受益人、登记者或申请人作出回应的通讯；
6. 与公共卫生紧急事件相关的通讯；
7. 与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前遗嘱相关的同意书和说明（可选择仅为所有捆绑在一起的文件提供一份通知）；
8. 出院文件；
9. 与个人医疗费用和支付相关的通讯，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第2799B–6条要求的善意估计；
10. 投诉表；以及
11. 患者和会员手册。

（d）如果受保障实体选择采取以下方式，则就该个人而言，应视为其已遵守本条规定：

（1）每年向该个人提供选择，使其可以选择退出以其主要语言并通过任何适当辅助器具与服务接收本条要求的通知，并且：

1. 不以该个人的退出决定作为接受任何援助或福利的条件；
2. 告知该个人其有权根据请求以其主要语言并通过适当辅助器具与服务接收通知；
3. 告知该个人退出接收通知并不等于放弃其依据本部分有权获得语言协助服务及任何适当辅助器具与服务的权利；
4. 每年记录该个人已选择退出接收当年本条要求的通知；以及
5. 不将个人的未回应视为退出决定；或者

（2）记录该个人的主要语言以及任何适当辅助器具与服务，并且：

1. 以该个人的主要语言并通过任何适当辅助器具与服务提供所有材料和通讯；或者

2. 在本条第（c）款第（5）项所列的所有通讯中，以该个人的主要语言并通过任何适当辅助器具与服务提供本条第（a）款要求的通知。

子部分B——反歧视条款

§ 92.101　禁止歧视

（a）一般规定。（1）除《平价医疗法案》（ACA）第一篇另有规定外，任何个人不得因种族、肤色、族裔出身、性别、年龄、残障或其任意组合，而被排除在受保障实体运营的任何健康计划或活动的参与之外、被拒绝享有其福利，或以其他方式在其中遭受歧视。

（2）基于性别的歧视包括但不限于基于以下方面的歧视：

1. 性别特征，包括间性特征；
2. 怀孕或相关状况；
3. 性取向；
4. 性别认同；以及
5. 性别刻板印象。

（b）具体的歧视禁止规定。（1）在本部分适用的任何健康计划或活动中：

（i）接受方和州级交易机构必须遵守本部门针对第六篇、第504条、第九篇和《年龄歧视法》的实施条例中关于歧视的具体禁止规定，这些条例分别见 45 CFR 第80、84、86篇（C子部分和D子部分）以及第91篇（B子部分）。在本款第（b）项交叉引用使用"接受方"一词的监管条款时……

第二部分　全国文化与语言适宜服务（CLAS）标准

全国CLAS标准旨在通过为健康和医疗保健机构制定行动蓝图，促进健康、提高质量并帮助消除医疗保健差距，以实现以下目标：

首要标准：

1. 提供有效、可理解且尊重他人的优质护理与服务，回应文化健康信念与实践、语言、健康素养及其他沟通需求。

治理、领导力与员工队伍：

2. 推动并维持通过政策、实践和资源配置促进CLAS的组织治理与领导力。
3. 招募、晋升、配备并支持能够回应服务人群的数字化、文化和语言需求的治理层、领导层和员工队伍。
4. 定期对治理层、领导层和员工队伍进行CLAS实践与资源方面的教育与培训。

沟通与语言协助：

5. 向英语能力有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以促进其及时获得所有医疗保健与服务。
6. 以书面和口头形式告知所有个人语言协助服务的可用性，使用英文以及满足其语言需求的其他语言。
7. 通过培训和认证（如有）确保提供语言协助人员的胜任能力，同时认识到应避免并劝阻使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译员。
8. 以服务区域人群常用的语言提供易于理解的数字和印刷材料及标识。

参与、持续改进与问责：

9. 制定文化和语言适宜的目标、政策与管理问责机制，并将其融入组织的规划和运营全过程。
10. 持续评估组织将CLAS相关活动和衡量指标纳入质量改进活动的情况。
11. 收集并维护准确可靠的人口统计数据，以监测和评估CLAS对健康结果的影响，并为服务提供提供参考。
12. 定期评估社区健康资源与需求，并利用评估结果规划和实施能够回应服务区域人群文化和语言需求的服务。
13. 与社区合作设计、实施并评估文化和语言适宜的实践及其影响。
14. 建立文化和语言适宜的流程，以识别、预防并解决冲突、投诉或申诉。
15. 向所有利益相关方、服务对象和公众传达组织在实施和维持CLAS方面取得的进展。

本中文翻译仅供参考，如有歧义以英文原文为准。